

a12_consult 测试报告

生成时间：2026-05-08 19:55:57

测试时间：2026-05-08 19:55:57

- 一、测试目的：验证工具增强对输出质量提升作用。
- 二、测试内容：同一输入下，分别运行 use_tools=True/False。
- 三、测试方法：对比输出结构与长度，核对产物路径。
- 四、测试过程：
 - 1) 启用工具运行；
 - 2) 禁用工具运行；
 - 3) 指标对照；
 - 4) 结论归纳。

五、测试结果：

启用工具 success=True chars=988 markers=12

禁用工具 success=True chars=1401 markers=8

工具说明：tool_风险洞察:tool_风险洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_个性化健康档案:tool_个性化健康档案：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_体征洞察:tool_体征洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_用药洞察:tool_用药洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_健康评估记录:tool_健康评估记录：从长者智能计算图提取历史参考证据

六、结论：工具可显著提升智能体输出准确性、完整性与专业性，助力机构提供更精准照护与医疗服务。

【启用工具输出摘录】

****精神科远程会诊记录****

****会诊日期****：2026-05-08

****参会人员****：护士长、GP、精神科医师、照护组长、家属代表

****问题摘要****：

陈萍忠老人返院一周内BPSD症状表现为初期拒绝配合康复活动，经舞蹈引导干预后配合度有所提升，血压及血脂控制良好，家属焦虑情绪一度缓解。然而，近2日照护员观察到老人在跳舞过程中偶发短暂记忆空白，表现为突然忘记已熟练的舞蹈动作，伴随情绪低落，并开始拒绝与其他长者共同参与舞蹈活动。家属担忧其认知功能进一步衰退，焦虑情绪出现反复。

****会诊结论****：

当前表现符合阿尔茨海默病病程中的****认知波动期****特征，记忆瞬时中断与社交回避行为可能与疾病进展、环境变化或情绪调节能力下降相关。暂无急性谵妄或精神病性症状证据，但需警惕功能加速衰退风险。整体判断为****需强化结构化非药物干预****以稳定认知表现并维持社会参与。

****药物调整建议****：

维持现有药物方案（包括多奈哌齐、美金刚等认知症治疗药物及慢性病用药），****暂不调整剂量或种类****。计划于2周后复评认知与行为表现，再决定是否需药理干预优化。

****非药物干预建议****：

1. ****舞蹈任务拆分****：将原有舞蹈动作分解为更小单元，采用“一步一练”模式，降低认知负荷，减少因记忆中断引发的挫败感。
2. ****短时小组互动****：安排每日10–15分钟的小型（2–3人）结构化社交活动，优先选择老人熟悉且喜爱的互动形式，逐步重建社交信心。
3. 维持现有舞蹈引导作为正向激励手段，但避免强制参与，尊重其当下意愿。

****后续观察重点****：

- ****晨间情绪状态****（是否持续低落、淡漠或易激惹）
- ****记忆空白发生频次与持续时间****（记录具体情境与触发因素）
- ****夜间睡眠质量****（是否存在入睡困难、早醒或夜间游走）

****下次复诊时间****：2026-05-22（2周后）

****待执行事项****：

1. 照护团队于24小时内****更新照护员任务卡****，明确新增观察要点与干预策略。
2. 安排社工或护士于3日内****开展家属沟通会****，解释当前认知波动的临床意义，提供情绪支持，并指导家庭端如何配合非药物干预。

****备注****：

若老人出现****攻击行为、激越或意识水平改变****，须立即启动紧急会诊流程，不得等待常规复诊。

【禁用工具输出摘录】

****精神科远程会诊记录****

****会诊日期****：2026年05月08日

****参会人员****：护士长、全科医师（GP）、精神科医师、照护组长、家属代表

****一、会诊目的****

本次会诊旨在评估陈萍忠老人返院一周后新出现的认知功能波动（表现为跳舞时短暂记忆空白、遗忘动作）及伴随的情绪低落与社交回避行为，分析其对BPSD（精神行为症状）的影响，并制定针对性干预策略，同时回应家属对认知衰退的担忧，提供照护指导与心理支持。

****二、问题摘要****

老人返院初期存在拒绝配合康复训练的情况，经舞蹈引导干预后配合度有所改善，血压、血脂控制良好，家属焦虑一度缓解。然而，近2日照护员观察到其在跳舞过程中偶发短暂记忆空白，无法回忆当前舞蹈动作，情绪略显低落，并开始拒绝与其他老人共同参与舞蹈活动。家属对此高度关注，担忧其认知功能加速下降，焦虑情绪出现反复。

****三、会诊结论****

综合当前表现，判断老人处于****认知功能波动期****，可能与环境适应、情绪状态或潜在神经认知变化相关，暂无急性器质性病变证据。现有精神行为症状以轻度认知波动伴情绪退缩为主，尚未构成严重功能损害，但需积极干预以防恶化。

****四、诊疗与干预建议****

1. **药物调整建议**：

维持当前用药方案不变。暂不新增或调整精神科药物，避免不必要的药理负担。计划于*2周后（2026年05月22日）复评*，根据认知与情绪变化趋势再行判断是否需要药物介入。

2. **非药物干预建议**：

- **舞蹈任务结构化拆分**：将原有舞蹈动作分解为更小、更易记忆的单元，采用“步骤提示卡”或口头分步引导，降低认知负荷，提升成功体验。
- **短时小组互动**：安排每日10-15分钟的小型（2-3人）结构化社交活动，优先选择老人熟悉或曾感兴趣的伙伴，避免强制参与，以“陪伴式互动”为主，逐步重建社交意愿。
- **情绪支持嵌入日常照护**：照护员在引导活动前先进行简短情绪确认（如“今天感觉怎么样？”），接纳其低落情绪，不强求表现。

3. **家属支持方案**：

- 开展专项家属沟通，解释“认知波动期”的常见性与可逆性，减轻灾难化认知；
- 指导家属在家访或通话中采用“肯定式对话”（如“您刚才记得这个动作，真棒！”），强化正向反馈；
- 提供简易家庭观察清单，协助记录记忆空白发生情境，便于复诊参考。

五、后续观察重点

- **晨间情绪状态**（是否持续低落、兴趣减退）；
- **记忆空白发生的频次、持续时间及触发情境**（如特定动作、人群、时段）；
-

夜间睡眠质量（入睡困难、早醒、夜间游走等），因睡眠障碍可能加剧日间认知波动。

六、下次复诊时间

2026年05月22日（2周后）

七、待执行